12. LE COEUR DIASTOLE & SYSTOLE

DURÉE : 05:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la dynamique essentielle des mouvements systoliques et diastoliques du cœur, en mettant l'accent sur leur impact sur l'énergie corporelle et les émotions. Vous apprendrez à observer les orientations verticales et horizontales du cœur, ce qui peut révéler des aspects cruciaux de la santé émotionnelle de vos patients. Les concepts de looping ventriculaire et d'interaction avec d'autres systèmes organiques comme le foie et les poumons montrent comment le cœur maintient une pression régulatrice dans son environnement fascial. Des techniques pratiques d'évaluation manuelle du cuir fascial et des mouvements permettent d'appliquer ces notions dans un cadre thérapeutique, tout en dévoilant aussi le lien entre le cœur et le diaphragme pour un bon fonctionnement rythmique et métabolique.

13 - LE CŒUR : DIASTOLE & SYSTOLE

Le **cœur** stocke de l'**énergie** dans un environnement **facial**, soutenant ainsi son **électricité**, tant dans sa phase ascendante que descendante.

Il existe une **prédominance innée** chez certaines personnes, qui peuvent manifester une fonction **systolique** ou **diastolique**. Un équilibre entre ces deux fonctions est normalement requis. Le cœur répète son mouvement embryonnaire de manière assez directe.

MOUVEMENTS DU CŒUR ET IMPLICATIONS ÉMOTIONNELLES

Un mouvement spécifique peut être ressenti. Par exemple, les personnes trop orientées vers un mouvement de **systole** sont souvent en recherche, mais peuvent aussi s'épuiser rapidement. À l'inverse, d'autres partent de ce point et cherchent constamment un point d'appui inférieur.

LE LOOPING VENTRICULAIRE ET LES PHASES CARDIAQUES

Le cœur effectue un **looping** caractéristique, où le système **ventriculaire**, initialement supérieur, devient inférieur, avec un point d'appui crucial entre les **oreillettes** et les **ventricules**.

- **Pendant la systole :**

* Le cœur effectue une **montée**.

* Il réalise un mouvement de **supination**.

* Il a tendance à se **verticaliser**.

* Il procède à une **détorsade**.

C'est à ce moment que l'**aorte** s'ouvre pour accueillir tout le sang, provoquant une **congestion**.

- **Pendant la diastole (descente) :**

* Tout le sang de l'aorte est éjecté dans le système.

Il est parfois facile de confondre le mouvement systolique avec le mouvement de descente. La systole est le moment de l'**éjection**. Quand le cœur redescend, il se **re-remplit**.

Lorsque le volume est éjecté, la pression dans le système de la crosse aortique augmente. Au moment de la descente, le cœur se remplit tout en éjectant l'aorte.

ORIENTATION DU CŒUR : VERTICALISATION VS. HORIZONTALISATION

Avez-vous l'impression que le cœur a tendance à se **verticaliser** ou à s'**horizontaliser** ? Est-ce qu'il se verticalise et monte, ou s'il s'horizontalise et descend ?

POINTS D'APPUI POUR L'OBSERVATION

Nous allons prendre trois points d'appui :

1. Au niveau de l'**espace aortique** (deuxième espace intercostal).

2. Au niveau de l'**espace pulmonaire**.

3. L'**éminence hypothénar** va se déposer sur la pointe du cœur.

LES SYSTÈMES INFLUENTS DU CŒUR

Le cœur réagit en fonction de deux grands systèmes qui lui sont très proches et tend à les aider au maximum :

- Le **foie**
- L'**estomac**
- Les **poumons**
- Les **reins**

Il cherche toujours à maintenir cette pression dans son environnement. Le cœur est un **régulateur de volume**. Il faut considérer le cœur comme une grosse artère se prolongeant avec l'aorte, comme un **octopus**.

MOUVEMENTS DE SUPINATION ET PRONATION

Nous aurons un mouvement de **supination**, puis un mouvement de **pronation**.

ÉVALUATION MANUELLE ET RÉACTIVITÉ FASCIALE

Nous allons observer l'environnement et comment il est agencé. Ensuite, nous placerons les mains au niveau du foie et observerons sa réaction sur un plan **fascial**.

L'aorte, si vous l'observez bien au niveau anatomique, part en fait assez en arrière, ce qui la rend difficile à visualiser. Cependant, elle partage un environnement fascial commun avec les **bronches** et l'**œsophage**, qui viennent s'insérer au niveau d'une vertèbre souvent en adaptation.

LES ZONES RYTHMIQUES ET LA RELATION DIAPHRAGMATIQUE

Il existe :

- Une zone **neurosensorielle**.
- Une zone **rythmique**.
- Une zone **métabolique**.
- Une zone **urogénitale**.

Pour un bon mouvement, le cœur doit avoir une bonne relation avec le **diaphragme**. Il existe une relation directe via la continuité fasciale de la crosse et de l'aorte.

Rappelez-vous le passage très profond de l'aorte, où les **piliers diaphragmatiques** s'insèrent de part et d'autre. Pour travailler le cœur, il est essentiel que le diaphragme soit **ouvert** et **souple**. N'oubliez pas l'autre passage important au niveau de l'œsophage.

APPLICATION PRATIQUE : SUIVI DES MOUVEMENTS FASCIALS

Nous avons étudié le **fulcrum embryonnaire pré-pattern** qui se positionne au niveau de la ligne primitive, au niveau du coccyx, avec le point d'arrivée.

Maintenant, plaçons la main au niveau du cœur et laissons-la suivre le mouvement fascial. Le tissu, si vous êtes attentif, vous indiquera si le cœur penche plutôt vers la systole ou vers la diastole.

Est-ce que c'est mon foie qui réagit ? Est-ce par rapport à mon estomac ? Ou est-ce par rapport à mes reins ? (Trois niveaux). Ensuite, nous observerons si cela peut se rééquilibrer par rapport à cette observation.